# Algoritmo CIF — Cervical

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Cervical. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b.

**REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.**

*Desvío desde el paso 3 si «SÍ»*

**3b ¿Rasgos neuropáticos, déficit de conducción o ninguno? Pueden coexistir; si el inicio fue traumático, el paso 2 ya añade el latigazo.**

- DOLOR RADICULAR → 12 Dolor Radicular Cervical
- RADICULOPATÍA → 3 Radiculopatía Cervical
- AMBOS → 12 Dolor Radicular Cervical + 3 Radiculopatía Cervical
- AURA MIGRAÑOSA → sin hipótesis
- FALLA LA MÉDULA → 8 Mielopatía Espondilótica Cervical

**1 ¿Existen signos de compromiso medular (mielopatía)?**

- **SÍ** — Alteración de marcha, hiperreflexia, signo de Hoffmann o Clonus positivos → 8 Mielopatía Espondilótica Cervical
- **NO** — Sin signos de mielopatía → sin hipótesis

todas →

**2 ¿Hubo un mecanismo de aceleración-desaceleración reciente (latigazo cervical)?**

- **SÍ** — ROM cervical significativamente reducido y síntomas de hiperalerta → 5 Trastornos Asociados a Latigazo Cervical (WAD)
- **NO** — Sin mecanismo traumático → sin hipótesis

todas →

**3 ¿El dolor baja por el brazo y es peor que el del cuello?**

- **SÍ** — Test de Spurling positivo, ULNT1 positivo o alivio con abducción del hombro → → desvío 3b
- **NO** — Sin irradiación predominante al brazo → sin hipótesis

SÍ ↑

NO →

**4 ¿El síntoma principal es cefalea unilateral o dolor en base del cuello/hombro?**

- **Cefalea unilateral** — Test de Flexión-Rotación Cervical <30° y síntomas C1-C2 → 4 Cefalea Cervicogénica
- **Cefalea primaria** — Criterios de migraña o tensional (el cuello puede contribuir) → sin hipótesis
- **Dolor en hombro/escápula** — Restricción de movilidad de 1ª costilla → 10 Disfunción de 1ª Costilla (Articulación Costo-Vertebral Superior)
- **Dolor local/inespecífico** — Sin cefalea ni irradiación dominante → sin hipótesis

**Todas → sigue en el paso 4b, en la página siguiente →**

Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

**Sin ninguna hipótesis al final:** dolor cervical inespecífico; revisar psicosociales y respuestas.
**Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 29/10/2026.

↓ Paso 4b: viene del paso 4

**4b ¿Hay mareo o inestabilidad como queja principal o acompañante? Descartar antes lo vascular (5 D y 3 N, disección).**

- **MAREO CERVICOGÉNICO** — Aturdimiento o inestabilidad ligados al cuello + error de reposición >4–5° → 13 **Mareo Cervicogénico**
- **VESTIBULAR** — Vértigo rotatorio; tras golpe en cabeza o cuello, pensar también en conmoción → sin hipótesis
- **NO** — Sin mareo → sin hipótesis

todas →

**5 ¿Cuál es la función más alterada en este paciente?**

- **Déficit de Movilidad** — ROM activo reducido y PAIVMs C0-C3 hipomóviles → 1 **Disfunción Articular Cervical**
- **Déficit de Coordinación** — CCFT alterado o test de reposicionamiento alterado → 2 **Disfunción Neuromuscular Cervical**
- **Déficit de Fuerza** — Reducción de fuerza de flexión o extensión cervical → 6 **Debilidad Muscular Cérvico-Escapular**
- **Déficit de Resistencia** — Fatiga muscular en actividades funcionales → 11 **Fatiga Muscular Cérvico-Escapular**
- **Déficit Postural** — Lordosis reducida o cabeza adelantada evidente → 9 **Disfunción Postural Cérvico-Torácica**
- **Dolor crónico inespecífico sin patrón dominante claro** → 7 **Dolor Mecánico Cervical Inespecífico Crónico**

todas →

**6 ¿Dónde está la disfunción? En todos: tarea provocadora, postura, control motor y región torácica.**

- **CRANEOCERVICAL (C1–2)** — Dolor en los primeros grados de rotación, restricción precoz, FRT <30° o 10° de asimetría → 14 **Dolor Cervical Idiopático**
- **FACETA CERVICAL** — Extensión-rotación positiva + disfunción segmentaria palpable y dolorosa → 14 **Dolor Cervical Idiopático**
- **CERVICAL BAJA Y CERVICOTORÁCICA** — Giro libre al inicio pero excursión final limitada → 14 **Dolor Cervical Idiopático**
- **NINGUNO** — No es idiopático o no se localiza → sin hipótesis

Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

**Sin ninguna hipótesis al final:** dolor cervical inespecífico; revisar psicosociales y respuestas.
**Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 29/10/2026.